



REGULAMENTO UCI

TÍTULO 13 REGULAMENTO MÉDICO

Versão em vigor a 05/02/2024

TÍTULO 13 – REGULAMENTO MÉDICO

Índice

Capítulo I – CÓDIGO MÉDICO DO MOVIMENTO OLÍMPICO

Capítulo II – OS ACTORES MÉDICOS NO CICLISMO

- § 1 Comissão Médica da UCI
- § 2 Médico da UCI
- § 3 Delegado Médico da UCI
- § 4 Médico Nacional
- § 5 Médicos de equipa
- § 6 Assistentes Paramédicos

Capítulo III – PROTEGER E PROMOVER A SAÚDE DOS CORREDORES

- § 1 Regras Gerais
- § 2 Acompanhamento médico das equipas WorldTeams e ProTeams
- § 3 Acompanhamento médico nas disciplinas Estrada Mulheres, BTT (XC), Pista e BMX
- § 4 Interdição de injeções
- § 5 Regresso à competição após uma concussão cerebral
- ~~§ 6 Interdição do tramadol em competição~~

Capítulo IV – SERVIÇOS MÉDICOS NO DECORRER DAS PROVAS

- § 1 Regras Gerais
- § 2 Campeonatos do Mundo UCI, provas da Taça do Mundo UCI e provas do UCI WorldTour

ANEXO A

ANEXO B

Capítulo I - CÓDIGO MÉDICO DO MOVIMENTO OLÍMPICO

- 13.1.001** Em 2009, O Comité Olímpico Internacional (COI) adoptou o Código Médico do Movimento Olímpico abaixo reproduzido.

O Código Médico do Movimento Olímpico não faz oficialmente parte do Regulamento do Ciclismo da UCI. Não se trata de regras da UCI nem de obrigações formais. Este expressa uma série de princípios, metas e objetivos destinados a guiar todos e todas que têm uma relação com a saúde e o cuidado dos atletas, e toda a atividade referida neste código, nomeadamente: os corredores, os seus médicos pessoais e os das equipas, as federações nacionais, os médicos das seleções nacionais, os assistentes paramédicos, os managers das equipas, os organizadores de provas de ciclismo e todo o pessoal médico que desempenhe um papel ou que esteja presente nas provas. É com este fim que o Código Médico do Movimento Olímpico é abaixo transcrito.

- 13.1.002** Recorda-se a todos que em caso de divergência com o Código Médico do Movimento Olímpico, prevalecerão as regras da UCI, em particular os capítulos de 2 a 4 abaixo indicados, bem como toda a legislação local.

Código Médico do Movimento Olímpico

Em vigor a 31 março de 2016

Versão em INGLÊS: “Olympic Movement Medical Code”

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/Who-We-Are/Commissions/Medical-and-Scientific-Commission/Olympic-Movement-Medical-Code-31-03-2016.pdf#_ga=2.162685628.1265859574.1613582383-1982745790.1613582383

Capítulo II - OS ACTORES MÉDICOS NO CICLISMO

§ 1 Comissão Médica da UCI

13.2.001 A Comissão Médica da UCI é definida pelo Comité Diretor da UCI.

O seu papel e as suas responsabilidades são definidas pelo Comité Diretor da UCI e pelo presente Regulamento.

Nota: a decisão do Comité Diretor da UCI de 18-19 de junho de 2009 que define o mandato da Comissão Médica da UCI está reproduzido no Anexo 1 do Título 13.

§ 2 Médico da UCI

13.2.002 O Médico da UCI é um médico nomeado pela UCI, que coordena o trabalho da Comissão Médica e é o seu porta-voz junto da UCI.

§ 3 Delegado Médico da UCI

13.2.003 A Comissão Médica nomeia um Delegado Técnico para os Campeonatos do Mundo à sua escolha. Este delegado assina uma declaração de confidencialidade assim que aceita o posto.

13.2.004 As responsabilidades do Delegado Médico da UCI são as seguintes:

1. Se for o caso, observar e aconselhar sobre a aplicação das regras UCI de proteção da saúde, bem como do Código Médico do Movimento Olímpico.
2. Familiarizar-se com o formato do relatório médico que o organizador terá que enviar à UCI, e verificar que as instalações médicas dos Campeonatos do Mundo são conformes e respeitam as regras da UCI.
3. Inspeccionar as instalações médicas junto com o Médico Chefe (MC) do Comité de Organização local (COL) na véspera da primeira sessão de treinos oficiais. O Delegado procederá a verificações regulares no decurso da prova, a fim de assegurar que as instalações médicas respeitam as regras da UCI e assinalar qualquer anomalia ao organizador e, a título de informação, ao Delegado Técnico da UCI.
4. No final de cada dia, obter do Médico Chefe a lista de corredores assistidos pelos serviços médicos bem como a dos corredores que tenham sido evacuados para uma unidade de assistência médica.
5. Visitar os corredores que tenham sido evacuados para uma unidade de assistência médica.
6. Ser a pessoa de contato com os médicos de equipa.
7. Receber as informações relativas aos corredores que constam da lista de participantes e que não querem alinhar à partida por razões médicas.
8. Coordenar os projetos de pesquisa no terreno empreendidos pela Comissão Médica.
9. Elaborar o relatório final dirigido à Comissão Médica da UCI relativamente aos serviços médicos do Campeonato do Mundo em questão.

13.2.005 O Médico oficial da UCI limita-se a verificar que as regras da UCI são respeitadas, e isto não transfere a responsabilidade dos serviços médicos do organizador para a UCI. Os casos de infração ao regulamento serão assinalados ao organizador, o qual tomará as medidas

necessárias e será inteiramente responsável pela segurança dos Campeonatos do Mundo, segundo as regras UCI e os termos do acordo de organização.

§ 4 Médico Nacional

- 13.2.006** Cada federação nacional nomeará um médico para a função de Médico Nacional. Dentro do possível, a federação nacional nomeará um médico com experiência em medicina desportiva.
- 13.2.007** O Médico Nacional estará ao corrente e assegurará a coordenação de todas as ações da federação nacional no domínio da saúde e da medicina.
- 13.2.008** O Médico Nacional deverá obter uma licença da UCI junto da federação nacional. A federação nacional inscreve o médico junto da Comissão Médica da UCI.
- 13.2.009** O Médico Nacional estabelece laços e coopera com a Comissão Médica da UCI.

§ 5 Médicos de equipa

- 13.2.010** Apenas os médicos titulares de uma licença de médico de equipa emitida pela sua federação nacional poderão ser contratados e nomeados pelas federações nacionais, equipas, sponsors, clubes, associações de ciclismo ou outro organismo do ciclismo, para prestar cuidados médicos aos corredores respetivos.
- 13.2.011** Neste contexto, cuidados médicos significa cuidados médicos amplos, nomeadamente nos seguintes domínios: visita médica dos corredores, verificação de aptidão para participar na competição, tratamento de lesões e doenças derivadas do desporto, prescrição de medicamentos a tomar durante uma atividade desportiva e conselhos sobre nutrição e treino.
- 13.2.012** A licença é emitida pela federação nacional do país de residência do médico. A federação nacional inscreve o médico junto da Comissão Médica da UCI.
- 13.2.013** A federação nacional estabelece as condições de obtenção de uma licença de médico desportivo.

De todas as formas, a pessoa em causa deverá ser detentora de um diploma de médico reconhecido, ter uma boa reputação, ser autorizado a exercer a medicina sem qualquer restrição, e, de preferência, ter conhecimentos no domínio da medicina desportiva.

- 13.2.014** Qualquer acordo ou prática que ligue a remuneração de um médico de equipa à performance de um ou mais corredor(es) são interditas.
- 13.2.015** A equipa assegura-se que todos os membros do staff e contratados encarregues de dar assistência aos corredores de qualquer natureza, consultam o médico da equipa para tudo aquilo que possa ter um impacto na saúde do corredor.
- 13.2.016** Além das obrigações contratuais com a equipa, o papel e as responsabilidades de um médico de equipa incluem:
 - 1. ter como preocupação principal prestar os melhores cuidados médicos possíveis aos corredores da equipa, quaisquer que sejam o seu nível e circunstâncias, e prever o tempo e o trabalho necessários para este fim;

2. continuar a aperfeiçoar-se no domínio da medicina desportiva;
3. adquirir e manter conhecimentos básicos no domínio médico-legal, da deficiência e da indemnização dos empregados;
4. adquirir e manter um conhecimento profundo das especificidades atléticas ligadas às disciplinas do ciclismo dos corredores da equipa;
5. coordenar a despistagem, as visitas médicas e as avaliações antes da participação numa prova;
6. prevenir e gerir as lesões e as doenças;
7. coordenar a re-educação e o retorno à competição;
8. prever uma preparação adequada para assegurar um regresso à competição sem riscos após uma doença ou lesão;
9. integrar a sua experiência médica com a de outros atores da saúde;
10. fornecer informações e conselhos úteis aos corredores em matéria de nutrição, treino de força e condicionamento, ergogénicos, abuso de substâncias, substâncias e métodos interditos e outros problemas médicos que os podem afetar;
11. fornecer documentação e gestão dos dossiers médicos adequadas;
12. participar em sondagens e outras iniciativas no domínio da saúde, destinadas a melhorar os cuidados médicos no ciclismo;
13. estabelecer e definir o papel de todas as partes no seio da equipa e as ligações entre elas relativamente à proteção da saúde;
14. colocar em prática uma cadeia hierárquica no seio da equipa para todas as questões relacionadas com a saúde;
15. informar o corredor, os pais (no caso dos menores), o manager da equipa, o treinador e as outras partes envolvidas em caso de preocupação relativamente a um corredor;
16. preparar um plano de ação e de se treinar para o aplicar em caso de urgência durante uma competição ou um treino;
17. tratar das questões relacionadas com os suprimentos e o material médico;
18. prestar a assistência médica necessária em caso de uma ocorrência;
19. avaliar os fatores ambientais, bem como as condições para os corredores.

As responsabilidades do médico de equipa não anulam e não afetam as responsabilidades que outras pessoas têm ao abrigo do Regulamento da UCI.

13.2.017 Qualquer violação por parte de um médico de equipa às obrigações que lhe são conferidas pelo presente título 13 do Regulamento da UCI poderá ter como consequência a imposição pela Comissão de Disciplina da UCI de um período de suspensão que poderá ir de oito dias a um ano e/ou uma multa entre 500 e 5.000 CHF. Em caso de segunda infração nos dois anos que se seguem à primeira, o médico de equipa será suspenso pelo menos durante seis meses ou definitivamente excluído, e passível de uma multa entre 1.000 e 10.000 CHF.

Se aplicável, uma infração poderá ser classificada como uma violação grave às boas práticas médicas.

O processo poderá ser, além disso, transmitido às autoridades disciplinares médicas do país em questão.

- 13.2.018** Qualquer infração aos artigos 13.2.010, 13.2.014 ou 13.2.015 poderá ter como consequência a imposição pela Comissão de Disciplina da UCI ao organismo em questão de um período de suspensão que poderá ir de um mês a um ano e/ou uma multa entre 1.000 e 10.000 CHF. Em caso de segunda ou nova infração nos cinco anos que se seguem à primeira, a penalização será uma multa entre 2.000 e 20.000 CHF, e/ou uma suspensão de pelo menos seis meses ou exclusão definitiva.
- 13.2.019** Se o caso diz respeito a um corredor que participou ou participa em provas inscritas no calendário internacional durante o ano da infração, a sua federação nacional deverá informar a UCI antes de iniciar um processo disciplinar. A UCI poderá exigir que um processo disciplinar seja iniciado de acordo com o seu regulamento antidopagem. Caso a UCI não reclame este direito nos quinze dias seguintes à data na qual a federação nacional em questão a informou do caso, a federação pode iniciar o processo disciplinar de acordo com o seu próprio regulamento.

§ 6 Assistentes Paramédicos*

Definição

- 13.2.020** O termo “assistente paramédico” significa qualquer pessoa que, de forma regular, a pedido ou por iniciativa direta ou indireta de uma federação nacional, de uma equipa, de um sponsor, de um clube, de uma associação de ciclismo ou de qualquer outra entidade de ciclismo, presta a um corredor qualquer tipo de cuidados paramédicos ou físicos ligados à preparação ou à participação em provas de ciclismo, nomeadamente administrando-lhe – sob a supervisão de um médico de equipa – medicamentos ou um tratamento em caso de lesão, e massagens.

***NT:** a função de paramédico não existe em Portugal. Deverá ser feita a correspondência, a nível de competências, às funções definidas pela legislação nacional como sendo profissional de saúde, estando sujeito a termos éticos e deontológicos. De forma operacional, define-se paramédico a todo e qualquer elemento pertencente a uma equipa com formação e certificação na área da saúde, na qual o médico responsável da mesma delegue funções de supervisão e cuidados de saúde ligados a preparação ou à participação em provas de ciclismo sob sua supervisão e conhecimento. Nenhuma função do paramédico deverá colidir com as funções ou desígnios do médico responsável, de forma a garantir a existência do cumprimento ético e deontológico inerente.

Licença

- 13.2.021** Com exceção dos médicos titulares de uma licença UCI de médico de equipa, ninguém poderá atuar enquanto assistente paramédico sem uma licença de assistente paramédico.
- 13.2.022** A licença de assistente paramédico é emitida pela federação nacional respetiva.
- 13.2.023** As condições para obtenção de uma licença de assistente paramédico são estabelecidas pelas federações nacionais. Estas condições devem garantir que estas licenças apenas serão emitidas a pessoas capazes de fornecer uma assistência de boa qualidade, que

respeita os imperativos da saúde e, se aplicável, as leis que governam o exercício dos profissionais de saúde. Apenas deverão ser atribuídas licenças a pessoas titulares de um diploma e que tenham continuado a aperfeiçoar no domínio dos serviços que deverão prestar aos corredores, que tenham conhecimento prático dos problemas médicos que afetam os atletas e conhecimentos de primeiros socorros básicos para um evento desportivo.

Regras de Conduta

- 13.2.024** O assistente paramédico prestará os melhores cuidados médicos possíveis aos corredores da equipa, quaisquer que sejam o seu nível e circunstâncias, e prever o tempo e o trabalho necessários para este fim.
- 13.2.025** O assistente paramédico deverá adquirir e manter um conhecimento profundo das especificidades atléticas ligadas às disciplinas do ciclismo dos corredores da equipa e continuará a aperfeiçoar-se nestes domínios de atividade.
- 13.2.026** O assistente paramédico respeitará e garantirá o respeito dos imperativos de saúde dos corredores, da deontologia desportiva e dos regulamentos da UCI e das federações nacionais. Está sujeito ao sigilo profissional e médico.
- 13.2.027** O comportamento do assistente paramédico servirá de modelo ao corredor.
- 13.2.028** O assistente paramédico colocará a saúde do corredor acima dos interesses eventuais da sua equipa, clube, sponsor ou seleção nacional que o poderiam prejudicar. Deverá opor-se à participação de um corredor em sessões de treino ou em provas, caso a proteção da saúde e da segurança deste não puderem ser garantidas. Terá um papel ativo na prevenção de lesões e na informação aos atletas.
- 13.2.029** O assistente paramédico evitará e lutará contra todas as situações e circunstâncias que tenham como risco um efeito nefasto para a integridade física ou o bem-estar físico do corredor.
- 13.2.030** O assistente paramédico limitará as suas atividades aos atos que a sua formação e experiência lhe permitem executar garantindo a sua qualidade e segurança.
- 13.2.031** Os cuidados prestados deverão corresponder às necessidades reais do corredor e às melhores práticas paramédicas. O assistente paramédico deverá abster-se de proceder a qualquer tratamento experimental.
- 13.2.032** O assistente paramédico deverá abster-se de executar qualquer ato que possa ser interdito pelas leis do seu próprio país ou do país onde exerce a sua profissão.
- 13.2.033** O assistente paramédico terá que seguir as instruções do médico no tratamento de um corredor doente ou lesionado.
- 13.2.034** Em especial, o assistente paramédico deverá abster-se de participar em atos e na utilização de métodos interditos pelo regulamento antidopagem da UCI e deverá recusar estar implicado.

Direitos Fundamentais do Corredor

- 13.2.035** O assistente paramédico não poderá executar nenhum ato a um corredor sem o consentimento deste.

- 13.2.036** O assistente paramédico informará o corredor da natureza e do objetivo de qualquer tratamento administrado, e das suas consequências.
- 13.2.037** O corredor tem o direito de ser informado de qualquer aspeto relativo à sua saúde ou ao seu estado psíquico ou físico que o assistente paramédico tenha constatado.
- 13.2.038** O assistente paramédico respeitará a vida privada do corredor e, desta forma, será discreto quanto aos cuidados administrados, com exceção da sua obrigação de divulgar as informações exigidas pelos ou em virtude dos regulamentos da UCI e das federações nacionais, ou uma disposição legal.

Sanções

- 13.2.039** Qualquer violação por parte de um assistente paramédico às obrigações que lhe são conferidas pelo presente título 13 do Regulamento da UCI poderá ter como consequência a imposição pela Comissão de Disciplina da UCI de um período de suspensão que poderá ir de oito dias a um ano e/ou uma multa entre 500 e 5.000 CHF. Em caso de segunda infração nos dois anos que se seguem à primeira, o assistente paramédico será suspenso pelo menos durante seis meses ou definitivamente excluído, e passível de uma multa entre 1.000 e 10.000 CHF.

Se aplicável, uma infração poderá ser classificada como uma violação grave às boas práticas médicas.

- 13.2.040** Qualquer pessoa, clube, equipa, federação ou outro organismo do ciclismo que contrate os serviços de uma pessoa que não seja titular de uma licença de assistente paramédico ou de médico para prestar cuidados a um corredor tal como descrito no artigo 13.2.020 será suspenso por um período de no mínimo um mês e que poderá ir até um máximo de um ano, e/ou será passível de uma multa de no mínimo 750 CHF e no máximo de 10.000 CHF. Em caso de nova infração nos dois anos que se seguem à primeira, a penalização será uma suspensão de pelo menos seis meses ou a exclusão definitiva e uma multa de no mínimo 1.500 CHF e um máximo de 20.000 CHF.
- 13.2.041** As sanções mencionadas no artigo 13.2.040 serão impostas a qualquer licenciado que preste cuidados a um corredor tal como definido no artigo 13.2.020, sem licença de assistente paramédico ou de médico, ou que seja cúmplice de uma infração cometida por um assistente paramédico, em particular incitando ou forçando o assistente paramédico a cometer atos que violem o presente regulamento.
- 13.2.042** Se os fatos dizem respeito a um corredor que participou ou participa em provas inscritas no calendário internacional durante o ano da infração, a sua federação nacional deverá informar a UCI antes de iniciar um processo disciplinar. A UCI poderá exigir que um processo disciplinar seja iniciado de acordo com o seu regulamento antidopagem. Caso a UCI não reclame este direito nos quinze dias seguintes à data na qual a federação nacional em questão a informou do caso, a federação pode iniciar o processo disciplinar de acordo com o seu próprio regulamento.

Capítulo III – PROTEGER E PROMOVER A SAÚDE DOS CORREDORES

§ 1 Regras Gerais

13.3.001 Cada corredor cuidará da sua própria forma física e prestará atenção aos riscos que podem ameaçar a sua saúde e segurança.

13.3.002 Cada equipa que participa em provas de ciclismo, assegurará constantemente e sistematicamente que os seus membros estão em boa forma para participar o ciclismo.

A equipa assegurará igualmente que os seus membros praticam a modalidade em boas condições de segurança. Esta garantirá, em particular, que um corredor esteja em boas condições de saúde quando retoma a competição após uma ausência.

13.3.003 No decorrer de uma prova de ciclismo, é responsabilidade da equipa ou do médico da corrida, caso exista, de determinar se um corredor lesionado pode continuar ou retomar a corrida. Esta decisão não pode ser delegada a outro profissional ou membro do pessoal. A prioridade deverá ser sempre dada à proteção da saúde e da segurança do corredor. O potencial resultado da competição não poderá nunca influenciar as decisões.

Se a opinião do médico da equipa diferir da do médico da corrida quando se trata de decidir se um corredor pode continuar ou retomar a prova, este último não poderá nem continuar nem a retomar.

13.3.004 Além do acompanhamento médico previsto pelo Regulamento da UCI, as federações nacionais têm toda a liberdade de ação relativamente à proteção da saúde e ao acompanhamento médico dos seus licenciados.

Uma visita médica antes de participar numa competição é recomendada para os atletas de alto nível. Esta deverá ser realizada sob a responsabilidade de um médico especialista.

13.3.005 No decorrer das provas inscritas no calendário internacional, não poderão ser organizados ou aceites nenhuns outros controlos que os previstos pelo Regulamento UCI. Isto é válido para o “período de competição” de cada prova tal como definido no regulamento antidopagem da UCI.

13.3.006 Cada equipa UCI WorldTeam e UCI ProTeam nomeia um médico, de preferência especialista em medicina desportiva, para a função de médico da sua equipa. As outras equipas registadas na UCI, farão os possíveis para nomear um médico, de preferência especialista em medicina desportiva, para a função de médico das suas equipas.

§ 2 Acompanhamento médico das equipas UCI WorldTeams e UCI ProTeams

Generalidades

13.3.007 Esta parte diz respeito as equipas UCI WorldTeams e UCI ProTeams.

- 13.3.008** Com os fins definidos no artigo 13.3.002, a equipa configurará e implementará um programa de prevenção e de segurança que incluirá no mínimo a lista dos exames exigidos e as medidas de prevenção dos riscos abaixo formulados.
- 13.3.009** O manager da equipa será responsável por organizar e implementar este programa. O médico da equipa será responsável pelos aspetos médicos.
- 13.3.010** A equipa não obrigará nem permitirá a um corredor participar em provas caso o médico da equipa não o considere apto para o fazer, ou se esta toma conhecimento por qualquer outro meio.
- 13.3.011** Caso o médico da equipa descubra um qualquer fato que, na sua opinião, signifique que o corredor não está apto (mesmo que temporariamente) para participar em provas, ele declara-o inapto e informa o manager da equipa. O período durante o qual o corredor será considerado inapto será determinado pelo médico da equipa. Esta decisão assim como a declaração de inaptidão serão consignadas por escrito e anexas ao dossier médico do corredor.
- 13.3.012** A equipa e o médico da equipa ajudarão o corredor a se tratar.
- 13.3.013** Para as competições com ou mais dias de duração, a equipa deverá obrigatoriamente fazer-se acompanhar por um médico, presente durante todo o desenrolar da prova.
- 13.3.014** Os médicos das equipas darão conhecimento à Comissão Médica da UCI dos riscos observados bem como de toda outra informação ou sugestão que possam ser úteis ao ciclismo em matéria de proteção da saúde, de medicina e de prevenção.

Exames

- 13.3.015** Os corredores devem submeter-se aos exames médicos descritos no “Programa de exames obrigatórios no âmbito do acompanhamento médico” elaborado pela Comissão Médica da UCI.

Este programa formula igualmente os procedimentos de implementação desta parte do regulamento. O programa é obrigatório para as partes implicadas, da mesma forma que este regulamento, e inclui as mesmas sanções.

O programa e as suas alterações entram em vigor a partir do momento em que as equipas são informadas.

- 13.3.016** Quando um corredor entra numa equipa pela primeira vez, o programa de exames obrigatórios deverá integrar um check up médico. A continuação, as visitas médicas ocorrerão de dois em dois anos, todos os anos e todos os trimestres como está previsto na tabela que faz parte deste programa.
- 13.3.017** Cada visita incluirá um exame físico realizado por um médico, preferencialmente com experiência em medicina desportiva, bem como os exames especiais estipulados no programa.
- 13.3.018** Os exames serão realizados de forma a que os resultados sejam conhecidos antes do final do período durante o qual devem ser realizados e possam formar a base de avaliação de aptidão do corredor para treinar ou participar em competições.

13.3.019 Os exames obrigatórios são realizados às custas da equipa.

Dossier Médico

13.3.020 O médico de uma equipa terá um dossier médico para cada um dos seus corredores.

13.3.021 Este dossier médico conterá todos os resultados dos exames que têm que ser realizados pelo corredor em questão em virtude das disposições do presente regulamento, bem como toda outra informação útil relativa à saúde do corredor, a qual será incluída com o seu consentimento.

13.3.022 O dossier médico pertence ao corredor, mas deve ser mantido pelo seu médico de equipa.

13.3.023 Não obstante o direito de verificação por parte da Comissão Médica da UCI de acordo com o artigo 13.3.028, apenas o corredor e o médico da sua equipa têm acesso ao dossier médico.

13.3.024 O médico da equipa, e se necessário for, a Comissão Médica da UCI tratarão os resultados dos exames como informações confidenciais, não obstante a obrigação que compete ao médico da equipa de declarar, se for o caso, que um corredor está inapto para treinar ou para participar numa competição.

13.3.025 O dossier médico será entregue ao corredor quando este deixa a equipa. O corredor transmite-o ao médico da sua nova equipa.

13.3.026 Todos os documentos datados de há 10 anos ou mais serão eliminados do dossier médico.

Controlos

13.3.027 Após cada exame, o médico da equipa submeterá uma declaração à Comissão Médica da UCI, conforme ao modelo redigido por esta última, mencionando os exames realizados por cada corredor. A Comissão Médica da UCI deverá receber esta declaração o mais tardar no dia 15 do mês seguinte ao da realização dos exames.

13.3.028 A pedido da Comissão Médica da UCI, nos prazos e segundo os procedimentos que esta fixe, o médico da equipa fornecerá a prova de que os exames obrigatórios previstos pelo presente regulamento foram realizados, bem como as explicações e informações solicitadas.

13.3.029 A Comissão Médica da UCI assegurará que nenhum dos seus membros ou qualquer outra pessoa não têm acesso às informações médicas dos corredores, com exceção dos seus médicos ou o médico da UCI.

Sanções

13.3.030 Em caso de infração às regras formuladas nesta parte, a Comissão Disciplinar da UCI pode impor as seguintes sanções:

À equipa: uma suspensão que pode ir de oito dias a seis meses e/ou uma multa de 1.000 a 10.000 CHF; em caso de infração ao artigo 13.3.027, a equipa receberá uma multa de 500 CHF por corredor e por semana de atraso.

Ao corredor: uma suspensão que pode ir de oito dias a três meses e/ou uma multa entre 100 e 1.000 CHF.

Ao médico da equipa: o previsto no artigo 13.2.017.

Ao manager da equipa: uma suspensão que pode ir de oito dias a dez anos e/ou uma multa de 500 e 10.000 CHF. Em caso de nova infração ocorrida no período de dois anos após a primeira, um mínimo de seis meses de suspensão ou a exclusão definitiva, e uma multa entre 1.000 e 10.000 CHF.

§ 3 Acompanhamento médico nas disciplinas Estrada Mulheres, BTT (XC), Pista e BMX

13.3.031 Esta parte trata as seguintes disciplinas: Estrada Mulheres, BTT (XC), Pista e BMX.

Os corredores e as corredoras a seguir indicados devem submeter-se ao programa de acompanhamento médico.

1. Equipas Femininas UCI;
2. BTT (XC): os 100 primeiros homens e as 40 primeiras mulheres do Ranking Individual da UCI, formato olímpico, a 31 de dezembro do ano precedente;
3. Pista: os 100 primeiros homens e as 40 primeiras mulheres do Ranking Individual da UCI, a 31 de dezembro do ano precedente;
4. BMX: os 20 primeiros homens e as 40 primeiras mulheres do Ranking Individual da UCI, a 31 de dezembro do ano precedente.

Generalidades

13.3.032 A federação nacional do(a) corredor(a) configurará e implementará um programa de prevenção e de segurança que incluirá no mínimo a lista dos exames exigidos abaixo formulada.

13.3.033 A federação nacional será responsável por organizar e implementar este programa. Caso a equipa não tenha um médico nomeado, o médico nacional ou um médico nomeado pela federação nacional (“o médico responsável”) será responsável das questões médicas. Este médico será titular de uma licença de médico de equipa.

13.3.034 A federação nacional ou a equipa de um(a) corredor(a) não o(a) obrigará nem permitirá a participar em provas caso o conselheiro médico o(a) considerou inapto(a), ou se esta toma conhecimento por qualquer outro meio.

13.3.035 Caso o médico da responsável descubra um qualquer fato que, na sua opinião, signifique que o(a) corredor(a) está inapto(a) (mesmo que temporariamente) para participar em provas, ele declara-o(a) inapto(a) e informa a sua equipa ou o seu clube. O período durante o qual o(a) corredor(a) será considerado(a) inapto(a) será determinado pelo médico responsável. Esta decisão assim como a declaração de inaptidão serão consignadas por escrito e anexas ao dossier médico do(a) corredor(a).

13.3.036 A federação nacional e o médico responsável ajudarão o(a) corredor(a) a se tratar.

Exames

13.3.037 Os(as) corredores(as) mencionados no artigo 13.3.031 devem submeter-se aos exames médicos descritos no “Programa de exames obrigatórios no âmbito do acompanhamento médico UCI” para as disciplinas de Estrada Mulheres, BTT (XC), Pista e BMX, elaborado pela Comissão Médica da UCI.

Este programa formula igualmente os procedimentos de implementação desta parte do regulamento. O programa é obrigatório para as partes implicadas, da mesma forma que este regulamento, e inclui as mesmas sanções.

O programa e as suas alterações entram em vigor a partir do momento em que são comunicados à federação nacional.

- 13.3.038** O programa de exames obrigatórios deverá integrar um check up médico auqndo da solicitação da licença. A continuação, as visitas médicas ocorrerão como previsto na tabela que faz parte deste programa.
- 13.3.039** No âmbito do acompanhamento médico, cada visita médica incluirá um exame físico realizado por um médico, preferencialmente com experiência em medicina desportiva, bem como os exames especiais estipulados no programa.
- 13.3.040** Os exames serão realizados de forma a que os resultados sejam conhecidos antes do final do período durante o qual devem ser realizados e possam formar a base de avaliação de aptidão do(a) corredor(a) para treinar ou participar em competições.
- 13.3.041** Os exames obrigatórios são realizados às custas da equipa (para os(as) corredores(as) que fazem parte de uma equipa registada) ou da federação nacional.

Dossier Médico

- 13.3.042** O médico responsável terá um dossier médico para cada um dos(as) corredores(as).
- 13.3.043** Este dossier médico conterá todos os resultados dos exames que têm que ser realizados pelo(a) corredor(a) em questão em virtude das disposições do presente regulamento, bem como toda outra informação útil relativa à saúde do(a) corredor(a), a qual será incluída com o seu consentimento.
- 13.3.044** O dossier médico pertence ao(à) corredor(a), mas deve ser mantido pelo seu médico responsável.
- 13.3.045** Não obstante o direito de verificação por parte da Comissão Médica da UCI de acordo com o artigo 13.3.049, apenas o(a) corredor(a) e o médico responsável têm acesso ao dossier médico.
- 13.3.046** O médico responsável, e se necessário for, a Comissão Médica da UCI tratarão os resultados dos exames como informações confidenciais, não obstante a obrigação que compete ao médico responsável de declarar, se for o caso, que um(a) corredor(a) está inapto(a).
- 13.3.047** O dossier médico será entregue ao(à) corredor(a) quando este(a) deixa de ser licenciado(a) da federação nacional em questão.
- 13.3.048** Todos os documentos datados de há 10 anos ou mais serão eliminados do dossier médico.

Controlos

- 13.3.049** A pedido da Comissão Médica da UCI, nos prazos e segundo os procedimentos que esta determine, o médico responsável fornecerá os resultados dos exames, bem como as explicações e informações solicitadas.

- 13.3.050** A Comissão Médica da UCI assegurará que nenhum dos seus membros ou qualquer outra pessoa não têm acesso às informações médicas dos(as) corredores(as), com exceção dos seus médicos ou o médico da UCI.

Sanções

- 13.3.051** Em caso de infração às regras formuladas nesta parte, a Comissão Disciplinar da UCI pode impor as seguintes sanções:

1. À equipa ou à federação nacional: uma multa de 1.000 a 10.000 CHF, em caso de infração ao artigo 13.3.037; a federação nacional receberá uma multa de 500 CHF por corredor(a) por semana de atraso.
2. Ao(à) corredor(a): uma suspensão que pode ir de oito dias a três meses e/ou uma multa entre 100 e 1.000 CHF.
3. Ao médico responsável: o previsto no artigo 13.2.017.
4. Ao manager da equipa do(a) corredor(a), dependendo do caso: uma suspensão que pode ir de oito dias a dez anos e/ou uma multa de 500 e 10.000 CHF. Em caso de nova infração ocorrida no período de dois anos após a primeira, um mínimo de seis meses de suspensão ou a exclusão definitiva, e uma multa entre 1.000 e 10.000 CHF.

§ 4 Interdição de Injeções

Nota: este tópico tem por objetivo a interdição de injeção de medicamentos ou substâncias que não tenham uma indicação médica precisa (ou seja, vitaminas, enzimas, cofatores, açúcares, aminoácidos, proteínas, antioxidantes, etc.). Trata-se em particular das injeções destinadas a melhorar ou acelerar a convalescença ou o combate à fadiga.

- 13.3.052** A injeção de qualquer substância em qualquer parte do corpo de um corredor é interdita, exceto se todas as condições a seguir indicadas estejam reunidas:

1. A injeção deverá ser justificada de acordo com as melhores práticas médicas profissionais. Este processo de justificação inclui um exame médico efetuado por um médico registado bem como um diagnóstico, os medicamentos prescritos e a precisão de uma via de administração corretamente documentados;
2. Não existe nenhum outro tratamento possível sem injeção;
3. A razão da injeção deve corresponder às indicações terapêuticas aprovadas pelo fabricante para o medicamento em questão;
4. A injeção deverá ser administrada por um profissional de medicina registado, exceto se a prática normal é que o paciente que sofre de uma doença que necessita de injeções se injete ele próprio (como por exemplo no caso da diabetes);
5. A injeção deverá ser assinalada imediatamente, e por escrito nas 24h, ao Médico da UCI (por email: medical@uci.ch ou por fax: +41 24 468 59 48), com exceção:
 - a. para os corredores com uma AUT válida;
 - b. para vacinação;

c. se a injeção é administrada no âmbito de um tratamento hospitalar ou de um exame clínico;

d. se a prática normal é que o paciente que sofre de uma doença que necessita de injeções se injete ele próprio.

O relatório deverá ser redigido por um médico que tenha examinado o corredor, e deverá confirmar nomeadamente que procedeu a um exame físico, e precisar o diagnóstico, os medicamentos prescritos e a via de administração. Se aplicável, conterá ainda a prescrição mencionada no artigo 13.1.065.

Nota ao ponto 5: o médico pode enviar o relatório ao corredor. O corredor é responsável do seu envio.

13.3.053 A interdição prevista no artigo 13.3.052 inclui todas as substâncias injetáveis, quer seja endógena ou exógena, e quer seja interdita em virtude do regulamento antidopagem da UCI ou não.

13.3.054 A interdição prevista no artigo 13.3.052 inclui todo o tipo de injeções: intravenosa, intramuscular, intra-articular, periarticular, peritendinosa, epidural, intradérmica, subcutânea, etc.

13.3.055 Em caso de injeção local de glucocorticosteroide, que é igualmente sujeito ao regulamento antidopagem da UCI e que faz parte da lista das substâncias interditas, o corredor deverá repousar e ser excluído da competição durante oito dias.

O médico que prescreveu a injeção prescreverá este repouso por escrito ao corredor e anexará uma cópia desta prescrição assinada por si e pelo corredor à documentação mencionada no artigo 13.3.051.1.

O médico que prescreveu ou o médico da equipa procederá a um controlo do cortisol sanguíneo imediatamente antes da retoma eventual da competição. A dosagem do cortisol será efetuada preferencialmente por um método de espectrometria de massa.

Os resultados desta dosagem e a decisão de aptidão médica para o regresso à competição serão enviadas pelo médico da equipa ao Diretor Médico da UCI de acordo com as mesmas modalidades previstas no artigo 13.3.052.5.

13.3.056 Se a substância injetada é uma substância interdita, é igualmente necessária uma autorização de uso para fins terapêuticos (AUT), além das exigências estipuladas nos artigos 13.3.052 e 13.3.055, deverá ser igualmente seguido o procedimento previsto no artigo 4 do regulamento antidopagem da UCI.

13.3.057 Em caso de infração ao artigo 13.3.052, poderá ter como consequência a imposição pela Comissão de Disciplina da UCI de um período de suspensão que poderá ir de oito dias a seis meses e/ou uma multa entre 1.000 e 10.000 CHF. Em caso de segunda infração nos dois anos que se seguem à primeira: suspensão de pelo menos seis meses ou exclusão definitiva, e uma multa entre 10.000 e 200.000 CHF.

As sanções são aplicáveis a qualquer licenciado caso seja descoberto que cometeu uma tal infração ou que foi cúmplice, sujeito à aplicação do artigo 1.1.086.

13.3.058 Além das sanções estipuladas pelo artigo 13.3.057, as seguintes medidas serão igualmente aplicáveis:

1. em caso de infração ao artigo 13.3.055, o conjunto dos resultados obtidos por um corredor nas 48h que se seguem serão objeto de desqualificação.

2. em caso de infração ao artigo 13.3.052 durante uma corrida, o(s) licenciado(s) em questão e, se aplicável, o conjunto da equipa do(s) licenciado(s) que cometeram a infração poderão ser excluídos da prova ; desta forma, a posse de objetos utilizados ou que possam ser utilizados para administrar uma injeção serão presumidos como a prova que uma infração ao artigo 13.3.052 foi cometida, exceto se estes objetos estiverem na posse de um médico que tenha redigido o relatório mencionado no artigo 13.3.052.5 e estejam cobertos por esse relatório e com exceção dos objetos que possam razoavelmente estar na posse de um médico. A exclusão pode ser decidida pelo Presidente do Colégio de Comissários depois de dar às pessoas implicadas a possibilidade de se exprimirem, ou pelo Presidente da Comissão de Disciplina da UCI com base nas informações fornecidas pelo Presidente do Colégio de Comissários.

13.3.059 Nas provas por etapas, os procedimentos disciplinares poderão ser acelerados e desenrolar-se de acordo com a decisão do Presidente da Comissão Disciplinar da UCI.

13.3.060 A eliminação de qualquer material utilizado para uma injeção será conforme as normas de segurança reconhecidas.

§ 5 Regresso à competição após uma concussão cerebral

13.3.061 Qualquer pessoa, e em particular qualquer médico e assistente paramédico, em presença de um corredor, serão vigilantes relativamente a sintomas de uma concussão cerebral.

13.3.062 Uma concussão cerebral é definida como um processo fisiopatológico complexo que afeta o cérebro, provocado por um traumatismo devido a forças biomecânicas. Para diagnosticar um caso de concussão cerebral grave, é geralmente necessário avaliar diversos aspetos, incluindo os sintomas clínicos, sinais físicos, o comportamento, o equilíbrio, o sono e a cognição.

13.3.063 Caso um ou mais dos elementos seguintes seja constatado, há razões para pensar que se trata de um caso de concussão cerebral.

1. Sintomas: somáticos (por exemplo: dor de cabeça), cognitivos (por exemplo: impressão de estar no nevoeiro) e/ou emocionais (por exemplo: labilidade)
2. Sinais físicos (por exemplo: perda de consciência, amnésia)
3. Comportamento incomum (por exemplo: irritabilidade)
4. Problemas cognitivos (por exemplo: tempo de reação mais longo do que o habitual)
5. Problemas de sono (por exemplo: sonolência).

13.3.064 Qualquer corredor suspeito de sofrer de uma concussão cerebral deverá ser imediatamente retirado da competição ou do treino e ser submetido urgentemente a um exame médico.

13.3.065 Para tudo o que diz respeito à boa avaliação clínica de um caso suspeito de concussão cerebral a gestão de um tal caso e o regresso ao treino e à competição, os médicos deverão seguir as diretrizes oficiais (Declaração consensual sobre as concussões

cerebral no desporto, 4ª Conferência Internacional, realizada em Zurique em 2012), bem como a Ferramenta 3 de avaliação dos casos de concussão cerebral no desporto (SCAT 3) e de todas as atualizações posteriores.

~~§ 6 Interdição do tramadol em competição~~

(Anulado em 05.02.24)

Capítulo IV – SERVIÇOS MÉDICOS NO DECORRER DAS PROVAS

§ 1 Regras Gerais

- 13.4.001** A preocupação principal de um organizador de provas de ciclismo será a proteção da saúde e da segurança de todas as pessoas envolvidas no evento.
- 13.4.002** O organizador de uma prova de ciclismo é responsável pela existência e o bom funcionamento dos serviços médicos da prova, de forma a providenciar os cuidados aos corredores, dirigentes, ao staff das equipas bem como ao da organização, aos jornalistas e a todas as restantes pessoas acreditadas que sejam vítimas de um ferimento ou que fiquem doentes no decorrer da prova.
- 13.4.003** O organizador deverá garantir que a assistência médica prestada no decorrer da sua prova tenha o melhor nível possível e seja eficaz em todos os aspetos, tendo em conta que qualquer atraso, erro ou indecisão poderão ter consequências graves.
- 13.4.004** A disponibilidade dos cuidados médicos será imediata em caso de acidente ou de aparição de sintomas (abordagem primária). O primeiro objetivo será de prestar os melhores cuidados possíveis para estabilizar o estado da pessoa em causa e, se necessário, de a evacuar o mais rapidamente possível para um hospital adequado.
- 13.4.005** O organizador deverá, no mínimo, designar um ou vários médicos encarregues de prestar os cuidados médicos no terreno, e fornecer uma ou várias ambulâncias. Os restantes serviços médicos dependem de todos os fatores pertinentes, nomeadamente, mas sem se limitar a estes:
1. A disciplina, a dimensão e o nível da prova;
 2. O número previsto de participantes, dos membros do staff logístico e de espetadores;
 3. As características geográficas, topográficas e ambientais; e
 4. As leis e práticas profissionais locais.
- 13.4.006** O organizador garantirá que todos os prestadores de serviços médicos são titulares da licença e autorizações profissionais necessárias, nomeadamente, para os veículos que conduzem.
- 13.4.007** Os serviços médicos estarão operacionais no local pelo menos 1 hora antes da partida de cada competição ou do início de uma sessão oficial de treino, sem interrupção até 1 hora após o último corredor ter terminado.
- 13.4.008** Além dos horários mencionados no artigo 13.4.007, um serviço 24h/24h será assegurado por pelo menos um assistente paramédico de serviço, ao qual poderemos solicitar uma assistência médica adequada, e que fale fluentemente inglês ou francês.
- 13.4.009** Antes da partida da prova, o organizador deverá ter disponível para as equipas participantes bem como para todos os membros do staff médico e da organização, um documento com o mapa dos postos médicos no terreno, o nome e o contacto telefónico dos membros do staff médico e dos hospitais a contactar caso seja necessário evacuar uma vítima.
- 13.4.010** O organizador fornecerá igualmente um serviço médico independente reservado ao público, de acordo com a legislação local e adaptado à dimensão da multidão esperada.

13.4.011 A responsabilidade dos serviços médicos é do organizador e em caso algum da UCI.

Os controlos que poderão eventualmente ser realizados por ou por conta da UCI limitam-se a verificar o respeito das regras da UCI, e isso não transfere a responsabilidade dos serviços médicos do organizador para a UCI. O organizador permanece exclusivamente responsável pela segurança da sua prova.

§ 2 Campeonatos do Mundo UCI, provas da Taça do Mundo UCI e provas do UCI WorldTour

13.4.012 As regras deste § 2 são relativas aos Campeonatos do Mundo UCI, provas da Taça do Mundo UCI e provas do UCI WorldTour.

13.4.013 O Comité de Organização Local (COL) fornecerá, no mínimo, os meios abaixo especificados. As leis locais e/ou as circunstâncias próprias da prova poderão tornar necessário outros meios complementares.

Recursos Humanos

13.4.014 O COL nomeará para a função de Médico Chefe (MC) um médico com conhecimentos em medicina desportiva e, se possível, com experiência na disciplina em questão. O MC assume o papel de coordenador geral dos serviços médicos da prova.

13.4.015 O COL fornecerá ainda ao MC a seguinte ajuda:

1. Um médico adjunto (dois nas provas de estrada), tendo de preferência formação em medicina desportiva, medicina de urgência ou em traumatologia, ou ainda especialidade em anestesiologia, e titular de um diploma de cuidados avançados de reanimação traumatológica (ATLS);
2. Em cada posto de socorro, uma equipa médica formada por um médico, um assistente paramédico* e um voluntário;
3. Em cada ambulância, um enfermeiro detentor da qualificação nacional profissional mais elevada no domínio dos cuidados avançados de reanimação (ALS) e um assistente paramédico*;
4. Para cada ambulância, um condutor titular da qualificação nacional mais elevada em matéria de transporte em ambulância;
5. Nas provas de estrada, na viatura do médico, um condutor com experiência na condução em provas de estrada.

***NT: Em Portugal define-se assistente paramédico em provas como um Tripulante de Ambulância de Socorro (TAS) ou equivalente, homologado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).**

13.4.016 O pessoal médico deverá usar uniformes facilmente identificáveis. Os médicos deverão ter a palavra “Médico” no seu uniforme.

13.4.017 Todos os médicos, e na medida do possível, todos os restantes membros do pessoal médico deverão falar fluentemente o inglês ou o francês.

Material

A. Veículos

13.4.018 O COL fornecerá:

1. Nas provas de estrada, uma viatura, de preferência de tipo cabriolet, destinada ao médico que assegura os primeiros socorros em caso de acidente e é responsável pela assistência de urgência;
2. Pelo menos duas ambulâncias destinadas aos acidentados e equipadas com material de reanimação cardio-pulmonar de urgência e de assistência avançada de reanimação; no mínimo uma ambulância deverá estar disponível a qualquer momento enquanto que a(s) outra(s) ambulância(a) está(ão) em serviço;
3. Tendo em conta a natureza da prova, a proximidade dos hospitais e a acessibilidade das vias de evacuação, os seguintes veículos serão igualmente fornecidos:
 - a) Os veículos capazes de transportar uma vítima numa maca em condições razoáveis nas estradas ou caminhos difíceis
 - b) Uma moto para permitir prestar rapidamente a assistência a um paciente quando é difícil fazê-lo em viatura (estradas estreitas, multidões na estrada, etc.)
 - c) Se a evacuação de uma vítima em ambulância demorar mais de 30 minutos, deverá estar disponível um helicóptero medicalizado, localizado o mais próximo possível e deverá permitir transportar um paciente em maca, a fim de minimizar o tempo de abordagem secundária; deverá existir uma área próxima do local da competição para permitir a aterragem do helicóptero;
 - d) Outros meios de transporte e de socorro adaptados à topografia do local de competição: socorristas de alta montanha, quads, etc.

B. Material Médico

13.4.019 O COL fornecerá todo o material médico da prova, o qual é colocado sob a responsabilidade do MC; este material incluirá, no mínimo, os equipamentos descritos no Anexo 2.

C. Comunicações

13.4.020 Todos os veículos, postos e unidades do serviço médico deverão estar interligados por um sistema de rádio profissional utilizando um canal de frequência especial, exclusivamente reservado ao serviço médico. O sistema de rádio deverá ter ligação ao canal de frequência dos comissários e organização.

13.4.021 Todos os membros do pessoal médico deverão estar equipados com rádios emissores/recetores, bem como com telemóveis caso o funcionamento dos rádios não seja o melhor.

13.4.022 O conjunto do pessoal médico deverá ter na sua posse a lista dos centros médicos de urgência e dos hospitais para os quais as vítimas poderão ser evacuadas, caso seja necessário, bem como os contactos dos serviços de socorro pertinentes.

No mínimo, o MC deverá poder contactar diretamente a direção destes serviços de socorro.

Repartição no Terreno

A. Provas de Estrada

13.4.023 Caso as condições sejam as normais, os serviços médicos são colocados da seguinte forma na caravana:

1. A viatura que transporta o MC ou o médico adjunto e um assistente paramédico posiciona-se atrás da viatura do Presidente do Colégio de Comissários;
2. A primeira ambulância posiciona-se no final dos carros dos diretores desportivos que acompanham o pelotão principal; uma segunda ambulância posiciona-se no final da caravana, próximo do carro vassoura; um dos médicos adjuntos deverá estar numa destas duas ambulâncias;
3. Se uma moto estiver disponível, esta transportará o segundo médico adjunto e colocar-se-á junto dos fugitivos nas etapas planas e ficará disponível no conjunto do percurso nas etapas de montanha.

13.4.024 Caso certas secções do percurso apresentem dificuldades técnicas suscetíveis de existirem quedas, o organizador fornecerá a todos os membros do pessoal médico um mapa do percurso indicando precisamente estas secções e as vias de acesso das ambulâncias bem como as vias de evacuação.

Um posto de socorro será implantado na proximidade de cada uma destas secções para permitir uma intervenção rápida em caso de urgência.

13.4.025 Se o percurso for um circuito, será igualmente instalado um posto médico central junto da linha de partida/chegada.

B. Outras disciplinas

13.4.026 A organização instalará um posto médico central numa estrutura permanente ou temporária, suficientemente grande para albergar o pessoal médico e o seu equipamento e prestar assistência às vítimas qualquer que seja a gravidade do seu estado. O posto médico central estará situado na zona de partida/chegada nas provas de BTT e de CRO, adjacente ao local de competição para o BMX, o Trial e o Indoor, e no interior do velódromo para as provas de pista.

A sua localização oferecerá boas possibilidades de acesso e de evacuação.

13.4.027 Caso certas secções do percurso de BTT ou de CRO apresentem dificuldades técnicas suscetíveis de existirem quedas, o organizador fornecerá a todos os membros do pessoal médico um mapa do percurso indicando precisamente estas secções e as vias de acesso das ambulâncias bem como as vias de evacuação.

Um posto de socorro será implantado na proximidade de cada uma destas secções para permitir uma intervenção rápida em caso de urgência.

Pelo menos um médico deverá estar também rapidamente disponível e em condições de se deslocar entre as diferentes secções.

13.4.028 Nas provas de pista, um posto de socorro estará instalado no centro da pista, para permitir uma intervenção rápida em caso de urgência.

13.4.029 Nas provas de BMX, o pessoal médico estará de prontidão na berma do percurso, nos locais onde as quedas são mais prováveis.

C. Regra especial para os Campeonatos do Mundo

13.4.030 O COL de um Campeonato do Mundo submeterá o plano dos serviços médicos para aprovação antecipada da Comissão Médica da UCI através do formulário de relatório médico da UCI.

O organizador enviará o formulário do relatório médico à UCI por correio eletrónico (medical@uci.ch) ou por fax (+41 24 468 59 48) pelo menos 3 meses antes do início da prova.

13.4.031 O Delegado Médico da UCI designado para os Campeonatos do Mundo em questão inspecionará as instalações médicas junto com o Médico Chefe, de acordo com o previsto no artigo 13.2.004.

ANEXO A

Decisão do Comité Diretor da UCI tomada na sua reunião de 18-19 de junho de 2009 em Lausanne que define o mandato da Comissão Médica da UCI

1. Mandato

- Aconselhar o Comité Diretor da UCI sobre todos os aspetos médicos do ciclismo e fazer recomendações;
- Cooperar com as outras comissões da UCI relativamente a qualquer questão de caráter médico;
- Redigir e publicar as diretrizes destinadas aos serviços médicos das provas de ciclismo;
- Supervisionar a aplicação das regras da UCI relativamente à segurança dos corredores e às condições desportivas;
- Realizar o acompanhamento dos serviços médicos nos campeonatos do mundo;
- Facilitar a informação médica aos treinadores e médicos;
- Ajudar os atletas, treinadores, managers e médicos de equipa a prevenir o doping, ressaltando em particular os riscos para a saúde.

No âmbito no seu mandato e orçamento, a comissão pode:

- Cooperar com as outras federações desportivas e os organismos médicos relativamente ao conjunto das questões ligadas à saúde no ciclismo;
- Facilitar as trocas de informação de carácter médico ligadas ao ciclismo;
- Prevenir e investigar sobre as lesões e doenças provocadas pelo desporto;
- Estudar, supervisionar e chamar a atenção para os aspetos biológicos do treino;
- Patrocinar, aprovar e organizar reuniões médicas suscetíveis de melhorar a segurança no ciclismo;
- Fornecer informações sob a forma de publicações;
- Fornecer documentação relativa a fisiologia do desporto, medicina desportiva e biomecânica.

2. Regra complementar

- Artigo 69 dos Estatutos da UCI
- Título 13 do Regulamento do Ciclismo

ANEXO B

Material médico mínimo exigido (conforme ao artigo 13.4.019)

O material médico incluirá pelo menos o seguinte:

1. Posto médico central

- Aparato de estabilização e transporte de doentes, com opção de estabilização vertebral (maca scoop, maca de vácuo ou Coquille);
- Oxigénio portátil
- Aparato de ventilação;
- Aparato de aspiração;
- Aparato de intubação de via aérea;
- Monitor ECG / desfibrilhador;
- Oxímetro de pulso;
- Colares cervicais de vários tamanhos;
- Estétoscópio e esfigmomanómetro;
- Fármacos de ressuscitação e sedo/analgesia/fármacos EV;
- Aparato de suporte básico de vida.

2. Postos de socorro (incluindo moto, se aplicável)

- Mala com aparato de ALS, com material de intubação, fármacos e dispositivos de invusão;
- Oxímetro, material de ventilação mecânica e oxigénio;
- Estétoscópio e esfigmomanómetro;
- Glucometro;
- Medicação endovenosa;
- Desfibrilhador;
- Mala ATLS contendo material de sutura e contenção.

3. Ambulâncias

- Aparato de estabilização e transporte de doentes, com opção de estabilização vertebral (maca scoop, maca de vácuo ou Coquille);
- Oxigénio portátil
- Aparato de ventilação;
- Aparato de aspiração;
- Aparato de intubação de via aérea;
- Monitor ECG / desfibrilhador;
- Oxímetro de pulso;
- Aparato de administração de fármacos EV;
- Estétoscópio e esfigmomanómetro;
- Aparato de imobilização (membros e ráquis), incluindo talas e colares cervicais;
- Kits de traqueostomia;
- Aparato de suporte básico de vida.

4. Helicóptero medicalizado, equipado de acordo com as normas nacionais locais